



Casos Clínicos — Prática Avançada

Introdução à Enfermagem (EN_430) • Questões Discursivas com Cenários Reais

10 casos clínicos

Integração de todos os módulos

🎯 **Como usar:** Leia cada caso clínico atentamente. Responda às questões discursivas aplicando os conhecimentos dos módulos do Guia Completo de Estudos. ⚠️ **IMPORTANTE:** Responda antes de consultar o gabarito comentado ao final de cada caso!

🕒 **Tempo sugerido:** 15-20 min por caso. | 📝 **Total:** 10 casos | 📋 **Questões:** 35 no total

1 Sra. Maria — Necessidades Básicas e SAE

Módulos 1-2

Sra. Maria, 72 anos, internada há 3 dias após AVE (Acidente Vascular Encefálico) com hemiparesia à direita. Encontra-se **consciente, L+O**, porém com **dificuldade para deglutir** (disfagia). Apresenta **incontinência urinária**, **imobilidade no leito** e **expressa preocupação** com sua recuperação, relatando: *"Estou com medo de não voltar a andar"*. SSVV: PA 150x90 mmHg, FC 88 bpm, FR 18 irpm, Tax 36,5°C, SatO₂ 96%.

1. Identifique **3 necessidades psicobiológicas** afetadas e **2 psicossociais** baseado na Teoria de Wanda Horta.
2. Elabore um **Diagnóstico de Enfermagem** (NANDA-I) para o risco mais iminente da paciente.
3. Descreva as **5 etapas da SAE** aplicadas a este caso, detalhando pelo menos uma intervenção para cada etapa.

✓ GABARITO COMENTADO

- ✓ **Necessidades psicobiológicas afetadas:** Locomoção (hemiparesia), Nutrição (disfagia/deglutição), Eliminação (incontinência urinária), Integridade cutânea (risco de LPP por imobilidade).
- ✓ **Necessidades psicossociais:** Segurança emocional (medo da recuperação), Autoestima (dependência para atividades básicas).
- ✓ **Diagnóstico NANDA-I:** "Risco de integridade da pele prejudicada relacionado a imobilidade física evidenciado por hemiparesia e restrição ao leito."
- ✓ **SAE:** (1) Histórico — coleta dos dados acima; (2) Diagnóstico — risco de LPP, déficit de autocuidado; (3) Planejamento — estabelecer mudança de decúbito 2/2h; (4) Implementação — realizar mudança de decúbito, avaliar pele; (5) Avaliação — verificar integridade da pele após 24h.

2 Sr. João — Anotação de Enfermagem e Terminologias

Módulo 3

Sr. João, 58 anos, pós-operatório de colecistectomia videolaparoscópica (retirada da vesícula). Está no 1º PO, **lúcido e orientado**, **deambulando**, **afebril**, **normocárdico** (FC 76 bpm), **eupnéico** (FR 17 irpm), **normotenso** (PA 125x80 mmHg). Apresenta ferida operatória limpa e seca. Refere **dor leve** no local (EVA 3/10). Aceitou dieta líquida sem intercorrências. Diurese presente e eliminou flatos.

1. Escreva uma **anotação de enfermagem completa** (estrutura SOAP) para este paciente no momento da visita.
2. Identifique e explique o significado de **5 terminologias técnicas** presentes no caso.
3. Qual(is) **sinais de alerta** você monitoraria nas próximas 24h? Justifique.

✓ GABARITO COMENTADO

- ✓ **Anotação SOAP:** S - "Refere dor leve (EVA 3/10) no local da F.O." O - "Paciente L+O, deambulando, afebril, normocárdico, eupnéico, normotenso. F.O. limpa e seca, com curativo oclusivo. Dieta líquida aceita. Diurese +, flatos +." A - "Pós-operatório imediato de colecistectomia, evoluindo bem." P - "Manter dieta conforme prescrição, analgesia, observação da F.O., estímulo à deambulação."
- ✓ **Terminologias:** Afebril (sem febre), Normocárdico (FC normal), Eupnéico (FR normal), Normotenso (PA normal), Lúcido e Orientado (consciente).
- ✓ **Sinais de alerta:** Febre (infecção), sangramento na F.O., retenção urinária, vômitos, dor intensa — todos indicam possíveis complicações cirúrgicas.

3 Sra. Ana — Administração de Medicamentos

Módulo 4

Você é o enfermeiro responsável pela Sra. Ana, 45 anos, internada na clínica médica com diagnóstico de **pielonefrite** (infecção renal). Prescrição médica:

- SF 0,9% 500 mL EV + 1g Ceftriaxona — 12/12h (correr em 30 min)
- Dipirona 500 mg IM (se dor ou febre)
- Heparina 5.000 UI SC (profilaxia TVP)
- Omeprazol 20 mg VO (jejum)

1. Aplique os **7 Certos da Medicação** para a administração do antibiótico (Ceftriaxona).
2. Qual a via correta da Heparina? Qual o **local de aplicação, ângulo e cuidados**?
3. Calcule as **macrogotas/min** do SF 0,9% para correr em 30 minutos. Fórmula: $\text{Volume} \div (\text{Tempo} \times 3)$.
4. A dipirona IM pode ser aplicada em quais **músculos**? Qual o volume máximo em cada um?

✓ GABARITO COMENTADO

- ✓ **7 Certos:** (1) Paciente — conferir pulseira/nome; (2) Medicamento — Ceftriaxona 1g; (3) Dose — 1g; (4) Via — EV; (5) Horário — 12/12h; (6) Registro — anotar após administrar; (7) Orientação — explicar sobre o antibiótico.
- ✓ **Heparina SC:** Via subcutânea. Aplicar no abdômen (2 dedos do umbigo), ângulo 45-90°, agulha fina. Fazer prega cutânea, não aspirar, não massagear local. Revezar quadrantes.
- ✓ **Cálculo:** $500 \text{ mL} \div 30 \text{ min} = 500 \div (0,5 \times 3) = 500 \div 1,5 = \sim 333 \text{ gotas/min}$.
- ✓ **Via IM:** Deltoide (2 mL), Vasto lateral da coxa (5 mL), Glúteo (4 mL). A dipirona 500 mg é 2 mL, cabe no deltoide. ângulo 90°, agulha 25x7 mm.

4 Sr. Pedro — Assepsia e Curativos

Módulos 5-6

Sr. Pedro, 65 anos, diabético tipo 2, internado para tratamento de **ferida infectada** no membro inferior direito (pé diabético). A ferida apresenta **exsudato purulento**, **odor forte**, bordas irregulares e **tecido necrótico** em 30% do leito. Classificada como **estágio 3 de LPP** em região calcânea. Glicemia capilar: 245 mg/dL.

1. Qual(is) **cobertura(is)** você indicaria para esta ferida? Justifique.
2. Descreva o **passo a passo do curativo** para esta ferida, incluindo os princípios de assepsia e antissepsia.
3. Quais **medidas preventivas** para lesão por pressão você implementaria neste paciente?
4. Explique a **técnica de calçar luvas estéreis** para este procedimento.

✓ GABARITO COMENTADO

- ✓ **Cobertura indicada:** Carvão ativado com prata (controle de odor e ação antimicrobiana) associado a alginato de cálcio (exsudato purulento). Realizar desbridamento do tecido necrótico.
- ✓ **Passo a passo:** (1) Higienizar mãos; (2) Calçar luvas de procedimento; (3) Remover curativo anterior; (4) Avaliar ferida; (5) Calçar luvas estéreis; (6) Limpeza com SF 0,9% (centro → periferia); (7) Secar bordas; (8) Aplicar cobertura; (9) Cobrir com gaze e fixar; (10) Desprezar resíduos; (11) Higienizar mãos; (12) Registrar.
- ✓ **Prevenção LPP:** Mudança de decúbito 2/2h, colchão piramidal, hidratação da pele, avaliar escala de Braden, proteger proeminências ósseas.
- ✓ **Luvas estéreis:** Abrir envelope pela parte externa. Calçar 1ª luva com mão dominante (pegar pelo avesso do punho). Calçar 2ª luva com dedos enluvados sob o punho dobrado. Mãos postas à frente.

5 Sra. Lúcia — Oxigenoterapia e Cateterismos

Módulo 7

Sra. Lúcia, 78 anos, com DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) agudizada, foi internada na emergência. Apresenta **dispneia intensa**, **cianose labial**, **SatO₂ 84%**, **FR 28 irpm**, **FC 110 bpm**, **PA 140x85 mmHg**. Ausculta pulmonar com **roncos e sibilos difusos**. Não consegue se alimentar por via oral. Apresenta **retenção urinária** (bexigoma palpável).

1. Qual **dispositivo de oxigenoterapia** é mais indicado para esta paciente? Qual fluxo e FiO₂ aproximados?
2. Justifique por que a **Máscara de Venturi** é preferível à máscara simples em pacientes com DPOC.
3. Quais **cateterismos** podem ser necessários? Indique o tipo e a finalidade de cada um.
4. Descreva os **cuidados de enfermagem** para a SNE (dieta) e para a sonda vesical de demora.

✓ GABARITO COMENTADO

- ✓ **Dispositivo:** Máscara de Venturi com FiO₂ controlada (24-28%) para evitar depressão respiratória por O₂ em excesso em pacientes DPOC. Fluxo conforme especificação da máscara.
- ✓ **Venturi vs Simples:** A Venturi fornece FiO₂ **exata e controlada**, essencial para DPOC que depende do drive hipóxico. Máscara simples não permite controle preciso.
- ✓ **Cateterismos:** SNE (dieta enteral — impossibilidade de deglutir); Sonda vesical de demora (controle de diurese e retenção urinária).
- ✓ **Cuidados SNE:** Verificar posicionamento (RX), manter cabeceira elevada, lavar sonda antes/após dieta, administrar dieta em gotejamento contínuo. **Cuidados sonda vesical:** Técnica estéril, fixar na coxa, manter saco coletor abaixo da bexiga, higiene do meato uretral.

6 Sr. Antônio — Exames, IMC e Balanço Hídrico

Módulo 8

Sr. Antônio, 55 anos, admitido com edema nos membros inferiores, dispneia e ganho de peso. Peso atual: **98 kg**, altura: **1,72 m**. Diagnóstico presuntivo: Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC). Prescrição: dieta hipossódica, restrição hídrica (1500 mL/dia), diurético EV. Coleta de exames: hemograma, urina 24h, eletrólitos.

1. Calcule e **classifique o IMC** do paciente conforme a OMS.
2. Explique como realizar a **coleta de urina 24h** e quais cuidados orientar ao paciente.
3. O paciente recebeu 500 mL de SF 0,9% EV e ingeriu 600 mL de água. Diurese: 800 mL. Calcule o **balanço hídrico** e interprete o resultado.

✓ GABARITO COMENTADO

- ✓ **IMC** = $98 \div (1,72)^2 = 98 \div 2,96 = 33,1 \text{ kg/m}^2$ → Classificação: **Obesidade Grau I** (30,0-34,9).
- ✓ **Urina 24h**: Desprezar a 1ª urina da manhã. Coletar **TODA** a urina das próximas 24h em frasco único (refrigerar). Incluir a 1ª urina da manhã do dia seguinte. Orientar o paciente a não perder nenhuma micção.
- ✓ **Balanço hídrico**: Ingesta = 500 + 600 = **1100 mL**. Perda = 800 mL (diurese). **Balanço = +300 mL** (positivo — reteve líquido). Em ICC, o balanço positivo indica sobrecarga hídrica e necessidade de ajuste na terapia diurética.

Sra. Joana, 82 anos, pós-operatória de fratura de fêmur (prótese de quadril). Encontra-se confusa, agitada no pós-operatório imediato, tentando retirar o dreno de Portovac e sentar-se sozinha, com alto risco de queda. Apresenta edema intenso no membro operado. Recusa o gelo prescrito.

1. Qual(is) **posição(ões)** são mais adequadas para esta paciente? Justifique.
2. Explique os **benefícios da crioterapia** no pós-operatório imediato e como realizá-la corretamente.
3. Descreva os **tipos de contenção** que podem ser considerados para evitar a retirada do dreno. Quais os **cuidados éticos e assistenciais** necessários?

✓ GABARITO COMENTADO

- ✓ **Posições:** Decúbito dorsal com membro operado ligeiramente elevado (reduzir edema). **Evitar** posição de Sims sobre o lado operado. Usar travesseiro/talas para manter o membro em posição neutra.
- ✓ **Crioterapia:** Reduz edema, dor e inflamação no pós-operatório. Aplicar bolsa de gelo envolta em pano por **20 minutos**, reavaliar a pele. Não aplicar diretamente sobre curativo. Explicar à paciente que o frio reduzirá a dor e o inchaço.
- ✓ **Contenção:** Mecânica (faixas de punho se necessário) como **último recurso**. Tentar primeiro contenção ambiental (grades, cama baixa) e química (sedação leve prescrita). **Cuidados:** Prescrição médica obrigatória, avaliar circulação a cada 1h, liberar a cada 2h, documentar, **NUNCA** como punição. Tentar reorientação verbal primeiro.

8 Sr. Carlos — Admissão e Processo Pós-Morte

Módulo 10

Sr. Carlos, 88 anos, chega ao hospital vindo de uma instituição de longa permanência, com histórico de AVE prévio, demência avançada, SNE para dieta e sonda vesical de demora. Apresenta rebaixamento do nível de consciência, dispneia e SatO₂ 78%. A família (filha única) está visivelmente abalada.

1. Descreva o **checklist de admissão** completo para este paciente.
2. Infelizmente o paciente evolui para óbito 2h após a admissão. Descreva os **passos do processo pós-morte** que o enfermeiro deve realizar.
3. Qual o **papel do enfermeiro** no apoio à família enlutada?

✓ GABARITO COMENTADO

- ✓ **Admissão:** (1) Pulseira de identificação; (2) Sinais vitais; (3) Histórico: HDA (queixa atual), HPP (AVE, demência), medicações, alergias; (4) Exame físico (atenção à SNE e sonda vesical); (5) Verificar dispositivos; (6) Orientar acompanhante; (7) Guardar pertences.
- ✓ **Pós-morte:** (1) Confirmar e registrar óbito; (2) Aguardar declaração de óbito (médico); (3) Posicionar corpo em decúbito dorsal; (4) Realizar higiene corporal; (5) Retirar dispositivos (SNE, sonda, cateteres); (6) Identificar corpo (pulseira + etiqueta); (7) Entregar à família; (8) Respeitar crenças religiosas.
- ✓ **Apoio à família:** Oferecer ambiente privado para despedida, comunicar com sensibilidade e clareza, permitir rituais religiosos, oferecer apoio psicológico, explicar os procedimentos, respeitar o tempo e as emoções da filha.

9 Sra. Denise — SAE + Medicação + Higiene (Caso Integrado)

Módulos 2-4-5

Sra. Denise, 70 anos, internada na clínica médica com pneumonia. Está **acamada**, em uso de **SNG** para medicação e dieta, **Cateter Nasal de O₂ a 3 L/min** (SatO₂ 91%). Prescrição: **antibiótico EV 8/8h**, **heparina SC 12/12h**. Apresenta-se **confusa**, com **incontinência fecal** e **pele íntegra** (sem LPP).

1. Elabore um **plano de cuidados de enfermagem** (Diagnóstico NANDA-I + Intervenções) para os **3 principais diagnósticos** desta paciente.
2. Descreva o **procedimento de higiene** (banho no leito) incluindo a sequência correta e os materiais necessários.
3. A SNG será usada para medicação. Quais os **cuidados na administração de medicamentos por sonda**?

✓ GABARITO COMENTADO**✓ Diagnósticos NANDA-I + Intervenções:**

1. "Troca de gases prejudicada" → manter O₂, monitorar SatO₂, posição Fowler, fisioterapia respiratória.
2. "Risco de integridade da pele prejudicada" → mudança de decúbito 2/2h, avaliar pele, hidratação, colchão adequado.
3. "Déficit de autocuidado para higiene" → banho no leito, higiene íntima após cada eliminação, troca de fraldas.

- ✓ **Banho no leito:** Materiais: bacia, água morna, sabonete, toalhas, luvas, roupa de cama, comadre.
Sequência: Olhos → face → braços → tórax → abdômen → MMII → períneo → dorso. **Cuidados especiais:** Proteger a SNG e o Cateter Nasal de O₂ durante o banho — evitar tração dos dispositivos, não molhar as fixações, verificar fixação adequada ao final do banho.
- ✓ **Medicação por sonda:** Verificar posicionamento da SNG, administrar cada medicação separadamente, triturar comprimidos (não triturar sublingual/LP/drágeas), diluir em 20-30 mL de água, lavar sonda entre cada medicação e ao final, manter cabeceira elevada.

10 Sr. Paulo — Caso Integrado Final (Todos os Módulos)

Todos os módulos

Sr. Paulo, 60 anos, vítima de acidente automobilístico, admitido na emergência.

Politraumatizado, consciente, L+O, com múltiplas escoriações e uma ferida corto-contusa na perna D, classificada como contaminada. PA 100x60 mmHg, FC 112 bpm, FR 24 irpm, SatO₂ 89%. Precisa de cateterismo vesical para monitorar diurese e acesso venoso periférico para reposição volêmica. Prescrição: SF 0,9% 1000 mL EV (correr em 1h), Vacina antitetânica IM, analgesia EV e curativo na ferida.

1. Com base na avaliação dos SSVV, identifique os **desvios dos parâmetros normais** e as **necessidades psicobiológicas prioritárias** (Teoria de Wanda Horta).
2. Calcule as **microgotas/min** do SF 0,9% para correr em 1h. Qual a importância desta reposição volêmica rápida?
3. A vacina antitetânica é administrada por via **IM profunda**. Qual músculo escolher e quais os cuidados?
4. Descreva a **técnica de curativo** na ferida contaminada, desde o preparo até o registro.
5. Redija uma **anotação de enfermagem completa (SOAP)** para o momento da admissão.

GABARITO COMENTADO

- ✓ **Desvios:** PA 100x60 (limítrofe — risco de choque), FC 112 (taquicárdico), FR 24 (taquipneico), SatO₂ 89% (hipóxia). **Necessidades prioritárias:** Oxigenação (SatO₂ baixa), Circulação (PA limítrofe + taquicardia compensatória — suspeita de choque hipovolêmico incipiente), Integridade cutânea (ferida contaminada).
- ✓ **Microgotas = Volume ÷ Tempo(h) = 1000 ÷ 1 = 1000 microgotas/min.** A reposição rápida visa estabilizar a hemodinâmica e prevenir choque hipovolêmico.
- ✓ **Vacina IM:** Músculo deltoide (2 mL) — normalmente a vacina vem em volume adequado. Aspirar antes de injetar, ângulo 90°, agulha 25x7 mm. Não massagear. Registrar lote e via.
- ✓ **Curativo contaminado:** (1) Luvas de procedimento; (2) Remover sujidades com SF 0,9%; (3) Calçar luvas estéreis; (4) Limpeza com SF 0,9% + PVPI tópico (movimento centro → periferia); (5) Aplicar carvão ativado ou cobertura antimicrobiana; (6) Cobrir com gaze estéril; (7) Fixar; (8) Registrar.
- ✓ **Anotação SOAP:** S - "Refere dor 8/10 na perna D." O - "Paciente L+O, PA 100x60, FC 112, FR 24, SatO₂ 89%. Ferida corto-contusa em perna D, contaminada." A - "Politrauma com sinais de choque hipovolêmico." P - "Instalado SF 0,9% 1000 mL EV (1000 mcgts/min), cateterismo vesical de demora instalado, vacina antitetânica aplicada no deltoide E, curativo realizado."

**Legenda de Desempenho:**

8-10 casos certos: Excelente!



5-7 casos certos: Bom, revise os módulos com erros



<5 casos certos: Revise o Guia Completo antes



Cada caso integra múltiplos módulos — o objetivo é aplicar o conhecimento de forma interdisciplinar, como na prática real!